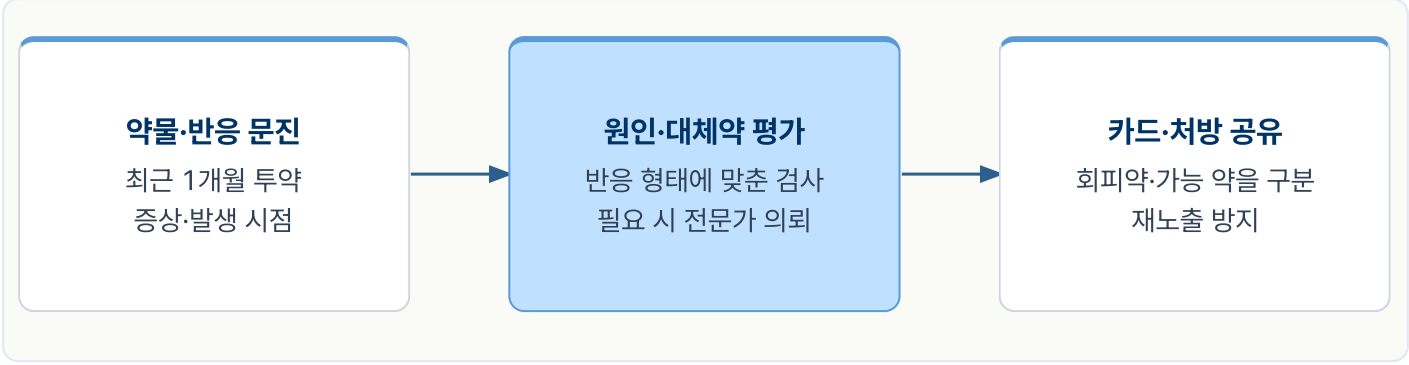
의료진 진료 카드 · ASL-077

약물 과민반응 · 기록과 휴대

'감기약 알레르기'로 끝내지 않고 원인 성분·반응·시점을 남긴다. 의료진이 평가 결과를 카드에 정리하는 원칙.

병력에서 평가를 거쳐 휴대 카드로



원인 평가에 필요한 기록

약 이름	성분명과 상품명을 연결. 처방 감기약·항생제·NSAID뿐 아니라 CT 조영제·근육이완제·항전간제·항결핵제·allopurinol 등도 조사.
시간 관계	최근 최소 1개월 약물 복용력, 과거 과민반응력, 약 투여와 증상 발생의 관계. 약을 먹은 직후 며칠만 묻는 데서 끝내지 않는다.
반응 형태	두드러기·혈관부종·아나필락시스, 반구진성 발진, 고정약진, 수포·점막 침범 등을 구분. 같은 부위에 반복되는 발진과 색소침착은 고정약진 단서.
시점 분류	강의 표: 즉시형 <1시간, 가속형 1~72시간, 지연형 >72시간. 반응의 형태와 시점을 함께 기록한다.

카드에 구분해 전달할 내용

회피 약물	평가된 원인 약 성분과 관련 회피 약물을 명시. '세파'라고 임의 판단해 실제 원인 NSAID를 재처방했던 고정약진 증례처럼 원인 오인을 피한다.
대체 약물	경구유발시험 등 평가로 복용 가능한 약과 용량 범위를 정리한다. 본강의는 '일반 NSAID는 안 되고 meloxicam·아세트아미노펜 어느 정도는 가능'처럼 기록하는 예를 설명.
의뢰·공유	의심 사례는 적절한 초기 대응 후 전문가 의뢰. 카드로 평가 결과를 받아 지역 의원에서 처방하도록 연결. 지역의약품안전센터 전화상담도 활용.

연자 Q&A: 수년간 잘 복용한 약도 평생 안전을 보장하지 않는다. 약 용량·컨디션·동반 요인과 반응형 변화에 따라 새 과민반응이 생길 수 있어, 카드의 '가능 약'은 실제 평가·내약성을 근거로 읽는다.

의료진 진료 카드 · ASL-077

기록을 읽을 때 · NSAID 반응형

과거 잘 먹었다는 사실만으로 현재 반응을 배제하지 않는다. 교차반응형과 선택적 반응형을 구분한다.

본강의 · NSAID와 대체약

교차반응	일반 NSAID·아스피린의 COX-1 억제 → PGE_2 감소·leukotriene 증가 → 두드러기·혈관부종/호흡기 반응. 다른 NSAID나 아스피린도 회피하도록 설명.
대체 가능성	선택적 COX-2 억제제 celecoxib, 약한 COX-1 억제 아세트아미노펜은 교차 가능성이 낮으나 예외 있음. 아세트아미노펜 <1,000mg을 약한 억제 용량으로 소개. 용량이 높으면 반응 가능.
검사	NSAID 병력이 확실하면 회피, 애매하거나 대체약을 찾을 때 경구유발시험. 본강의는 통상 피부·혈액검사로 원인을 찾기 어렵다고 설명. 유발시험은 응급약과 의료진 대기 상태에서 시행.

연자 Q&A · 선택적 반응과 내약성

반응형 구분	특정 NSAID 또는 화학적으로 유사한 약에만 반응하고 구조가 다른 약은 복용 가능한 선택적 면역반응(SNIUAA)과 COX-1 교차반응형을 구분한다고 답변.
실제 복용 사례	Ibuprofen 반응 후 aceclofenac을 수년간 복용한 사례: 현재 임상적 내약성의 단서이나, 용량·컨디션·cofactor에 따라 달라질 수 있다고 답변.
진통·해열 선택	교차반응성은 celecoxib가 매우 낮은 편, 단순 해열·진통에는 이전에 잘 복용한 아세트아미노펜이 실용적. celecoxib도 전문의 감독 유발시험으로 내약성 확인이 가장 확실하다고 답변.

이상반응과 알레르기는 구분해 기록

Type A

용량·약리작용과 관련되어 예측 가능한 반응. 강의 예: 항히스타민제 졸림. 전체 이상반응 약 90%.

Type B

면역·특이체질과 관련한 예측하기 어려운 과민반응. 약 10%이나 아나필락시스·중증 피부반응처럼 중대한 반응이 포함.